

Fecha Última Actualización: 25-07-2024 2:38:08

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Ruben Dario Bravo Andrade
Edad : 65a 0m 10d
Dirección : Comercio 18829

Rut : 8.461.205-7
Fecha Nacto: 15/07/1959
Comuna : San José De M
N° Archivo : A177375
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7324 0567

N° Epicrisis
407503

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Básica Coronaria

Fecha Ingreso : 17/05/2024 18:40

Días Estadía: 69

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 25/07/2024 02:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor toracico.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

EPICRISIS.

Nombre: Ruben Bravo Andrade

RUT: 8461205-7

FECHA DE EGRESO UPC: 25/07/24. 02:16 horas.

ESTADO FALLECIDO.

·Antecedentes médicos y quirúrgicos:

oHTA

·Fármacos de uso crónico:

oLosartán 50 mg. cada 12 horas VO

·Alergias: No

·Hábitos: TBQ (+) (activo, IPA estimado 30), OH (-), Drogas (-)

·Social: Autovalente, agricultor

Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos, consulta el 17/05/2024 inicialmente en HSJM por dolor torácico de tipo opresivo autolimitado de 10 minutos de duración con irradiación hacia ambas extremidades superiores, además de náuseas. Al interrogatorio dirigido refiere episodios similares desde hace aproximadamente 6 meses. Niega disnea, niega compromiso de conciencia, niega otros síntomas. Es derivado a UEA CASR donde ingresa en cuanto a hemodinamia estable aunque hipertenso, normocárdico, afebril, sin req. de O2 suplementario.

Se describe a la evaluación en buenas condiciones generales y sin hallazgos de carácter patológico agudo al examen físico segmentario. ECGs seriados sin cambios dinámicos (RS con EV frecuentes, IDST difuso con SDST en aVR y V1 límite sin evolución) y con tropoUS elevada (489.9 - 265.1). Destaca además en laboratorio al ingreso alza de creatinina y BUN (2.92 y 56.4, no contamos con históricos en sistema). Se realiza estudio coronario invasivo en hemodinamia: TCI con lesión severa distal, ADA con irregularidades en tercio medio, ACx con lesión severa ostial y ACD dominante con lesión severa proximal, además con sospecha de estenosis aórtica severa.

Se realiza ecocardiograma formal el 22/05 destacando dilatación severa de AI y leve hipertrofia de pared ventricular izquierda con función sistólica global conservada, FEVI estimada preservada (60%) y sin alteraciones de motilidad segmentaria; en

Fecha Epicrisis : 25/07/2024 02:38

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 25-07-2024 2:38:08

Página 2 de 4

cuanto a VAo válvula calcificada con estenosis moderada (V_{max} 3.2 m/s y DVI 0.29) y con área de 0.8 cm² e insuficiencia leve, y además insuficiencia mitral mínima. Se indica MAPT con AAS y atorvastatina, además de titulación de terapia vasodilatadora, e ingresa a Unidad Coronaria en espera de revascularización miocárdica quirúrgica y de recambio valvular aórtico.

Diagnósticos de ingreso:

- IAM sin SDST
- oEnfermedad coronaria de TCI y 2 vasos
- Estenosis aórtica moderada
- Enfermedad renal en estudio
- Antecedentes:
- oHTA, tabaquismo

Evolución durante estadía hospitalaria por planes:

Cardioquirúrgico y quirúrgico: Ingres a unidad coronaria estable en espera de revascularización miocárdica quirúrgica. Se realiza intervención el 24/05/2024 (recambio valvular aórtico con prótesis biológica C-E #23, y revascularización habitual con anastomosis de a. mamaria interna izquierda a a. descendente anterior, puente aorto-coronario con injerto de vena safena a la lateral alta de la a. circunfleja y puente aorto-coronario con injerto de vena safena a la descendente posterior de la a. coronaria derecha, con tiempo de CEC 145' y Clamp de 106', con req. de TR de 2 UI GR y sin incidentes reportados). Destaca extensa enfermedad ateromatosa aórtica. Al egreso con perfil más bien hipertensivo, con cifras tensionales bien controladas tras titulación de fármacos.

El 28/05 tras retiro de drenajes evoluciona con shock inicialmente indiferenciado con un perfil que impresiona predominantemente hipovolémico y con PCR con ROSC exitoso tras 1 ciclo de reanimación clínicamente mal perfundido, a la ecoscopia sin signos de taponamiento ni rotura, con ECG sin cambios respecto a previos. Se realiza AngioTC en que se visualiza hemotórax izquierdo de cuantía moderada sin identificar sitios de sangrado activo. Se realiza pleurostomía el 29/05, con débito de 700 cc. durante las primeras 24 horas descrito como "hemático antiguo". Por franco deterioro e inestabilidad hemodinámica se solicita exploración en pabellón, realizándose el 03/06 (esternotomía exploradora), visualizándose hemotórax organizado y extrayéndose aproximadamente 1500 cc. de coágulos descritos como antiguos (se revisan a nastomosis, sin sangrad o); egresa grave a Unidad Coronaria con req. moderados/altos de DVA.

Tras nuevo hit y shock que impresiona séptico en TC destaca neumoperitoneo libre asociado a signos de peritonitis con alta sospecha de víscera hueca. Se realiza laparoscopia exploradora el 08/06 convertida a laparotomía por peritonitis fecaloidea de 4 cuadrantes secundaria a perforación de divertículo colónico; se realiza cirugía de Hartmann con resección de 15 cm. de colon sigmoides y aseo abundante, con exteriorización de colostomía terminal en flanco izquierdo. Egres a de pabellón inicialmente grave con req. moderados/altos de DVA, con posterior estabilización progresiva de macrohemodinamia. Por fiebre persistente y parám. inflamatorios estacionarios se realiza nuevo TC el 20/06 visualizándose colección organizada multiloculada subcapsular hepática además de colección en línea media en partes blandas de pared abdominal (la segunda impresiona de carácter postquirúrgico). Se solicita punción de dicha colección por radiología intervencional, concretándose finalmente el 01/07, con cultivo (+) para c. glabrata.

Paralelamente por derrame pleural derecho moderado se instala drenaje pleural por cardiocirugía el 28/06; tras retiro evoluciona con gran enfisema subcutáneo, se solicita TC (además para descartar neumotórax) en que se observa extenso enfisema de partes blandas que se extiende a través de la región temporal derecha, espacios profundos y superficiales del cuello bilateralmente, partes blandas del hemitórax derecho y del hemiabdomen derecho. Evaluado por cirugía, sin req. de tratamiento ni intervención, en plan de resolución espontánea; clínicamente con evolución favorable aunque en TC de control del 09/07 se describe progresión de enfisema subcutáneo respecto a imagen previa. En plan de mantener control imagenológico seriado, con evaluación SOS si requiere por parte de cirugía.

Hemodinamia: Al ingreso estable, sin signos sugerentes de falla cardíaca y sin conflicto en cuanto a perfusión. Deterioro hemodinámico intermitente durante estadía principalmente en relación a hits quirúrgicos descritos y a infecciosos, actualmente macrohemodinamia estable, con escasos req. de DVA (NAD 0.03), bien perfundido clínicamente tibio a distal, con buena tolerancia a SLED programada para hoy por nefrología.

Ventilatorio: En lo ventilatorio inicialmente VMI por IOT en contexto de recambio valvular y revascularización miocárdica programada, con extubación programada precoz tras cirugía el 24/05/2024, luego 3 procesos de weaning frustrados:

- IOT 28/05/2024 en contexto de shock hipovolémico - hemotórax izquierdo descrito, se desestima en ese entonces req. de

Fecha Epicrisis : 25/07/2024 02:38

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 25-07-2024 2:38:08

Página 3 de 4

exploración o aseo, instalándose pleurostomía con débito de aproximadamente 700 cc. las primeras 24 horas. Extubado el 06/07/2024.

·IOT 08/06/2024 en contexto de nuevo hit, peritonitis estercorácea con req. de laparoscopia exploradora convertida a laparotomía exploradora con aseo y cirugía de Hartmann por perforación de divertículo colónico. Extubado tras PVE exitosa y mejoría de hemodinamia el 15/06/2024.

·IOT 28/06/2024 impresiona falla ventilatoria primaria multifactorial, en contexto de miopatía, uremia (BUN > 80) y sepsis concomitante, en TC enfisema, escasas opacidades centrolobulillares y de predominio peribroncovascular, leve derrame pleural bilateral y atelectasia parcial de ambos lóbulos inferiores con mínimo neumotórax derecho.

Considerando 3 procesos de weaning previos frustrados, se gestiona traqueostomía percutánea, que se realiza el 03/07. Desde entonces si conflicto en cuanto a intercambio gaseoso, pero con acople de calidad intermitente a VMI, con evidencia en TC de bronquiolitis probablemente infecciosa en ambos lóbulos inferiores probablemente de etiología aspirativa, y con mala respuesta tras descenso de sedación y superficialización de conciencia por aumento de drive ventilatorio y mal acople durante jornadas previas. Hoy bien acoplado, en SAS II, con VMI en modalidad C-PAP 6/12, con FiO2 al 24% y PaFi > 400.

EVOLUCION EN UPC.

Ingresado proveniente de conario, en el contexto de debilidad del paciente critico asi como weaning dificultoso.

Se inicia optimizacion de deficiencias, se continua con HD agudo.

Paciente evoluciona en condiciones estables en la unidad hasta el 22/07/24 donde inicia cuadro de hipotension, registro febril compatible con bacteremia.

Se indica pancultivo asi como antibioticos de tercera linea. Por hallazgo de candidemia se inicia antifungicos parenterales.

Se evidencia en estudio por imagenes, abdomen agudo perforativo, obs Diverticulo perforado con peritonitis difusa. Se realiza cirugía de salvataje.

Paciente evolucion con cuadro septivo progresivo--> shock septico con FMO, por lo que se decide realizar HFAV. La misma que se prolonga por 24 horas, sin respuesta en su evolucion.

Paciente evoluciona con shock refractario a pesar de tratamiento .

Realiza PCR en asistolia, se inicia RCP sin respuesta.

Se declara fallecido: el 25/07/24 a las 02:16 horas.

Se entrega certificado de defuncion.

Diagnosticos de egreso.

SHOCK SEPTICO REFRACTARIO.

FMO.

SEPSIS FOCO ABDOMINAL.

INSUFICIENCIA CARDIACA .

ENFERMEDAD CORONARIA.

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico - falla multiorganica

Condición de Egreso Fallecido

paciente fallecido.

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Fecha Epicrisis : 25/07/2024 02:38

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 25-07-2024 2:38:08

Página 4 de 4

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Jorge Tapia Rivadeneira
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/07/2024 02:38

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:09

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar